

PACIENTES SIN AFASIA NI HEMIPARESIA EN MANO DOMINANTE EVIDENTES

Funciones atencionales y ejecutivas:

Control mental WMS-III*.
Dígitos directos e inversos de la WAIS-III**.
Trail Making Test A y B o Stroop Color Word Interference Test.
Symbol Digits Modalities Test, versión oral.
Cálculo mental o escrito.
FAS (palabras que empiecen por F, A y S).

Lenguaje:

Boston Naming Test 30 ítems.
Token Test o comprensión de órdenes BDAE***.
Repetición de pseudopalabras BDAE.
Repetición de frases BDAE.
Animales, durante 1 minuto.

Memoria:

Audioverbal: lista de 15 palabras de Rev.
Visual: WMS-III dibujos.
Orientación temporal Benton.
Animales, durante 1 minuto.
Trabajo: dígitos inversos WAIS-III.

Funciones visuoperceptivas, visuoespaciales y visuomotoras:

Discriminación de formas WMS-III.
Copia de dibujos WMS-III.
Orientación de líneas de Benton.
Hooper Visual Organization Test (con componente ejecutivo).

Control motor cognitivo voluntario:

Grooved Pegboard o Finger Tapping.
Copia de dibujos WMS-III.

Velocidad:

Motora: Grooved Pegboard o Finger Tapping en mano dominante y no dominante.
Procesamiento de información: Symbol Digits Modalities Test, versión oral.

Protocolos generales Vall d'Hebron, para la evaluación neuropsicológica en patología vascular cerebral adaptados a secuelas neurológicas a realizar en estadios iniciales de la demencia. *Wechsler Memory Scale- III** Escala de Inteligencia para Adultos – III*** Boston Diagnostic Aphasia Examination

PACIENTES CON AFASIA EVIDENTE

Funciones atencionales y ejecutivas:

Corsi's Block Tapping Test directos e inversos.
Trail Making Test A y B.
Symbol Digits Modalities Test, versión escrita.
Cálculo escrito.
Ruff Figural Fluency Test (equivalente visuográfico al FAS).

Lenguaje:

Boston Naming Test 30 ítems.
Token Test o comprensión órdenes BDAE, según el nivel de alteración.
Repetición pseudopalabras BDAE.
Repetición frases BDAE.
Animales, durante 1 minuto.
FAS

Memoria:

Visual: WMS-III dibujos.
Orientación temporal de Benton en láminas (señalar).
Trabajo: Corsi's Block Tapping Test inversos.

Funciones visuoperceptivas, visuoespaciales y visuomotoras:

Discriminación de formas WMS-III.
Copia dibujos WMS-III.
Orientación de líneas de Benton.
Hooper Visual Organization Test (con componente ejecutivo).

Control motor cognitivo voluntario:

Grooved Pegboard o Finger Tapping.
Copia dibujos WMS-III.

Velocidad:

Motora: Grooved Pegboard o Finger Tapping en mano dominante y no dominante.
Procesamiento información: Symbol Digits Modalities Test, versión escrita.

Protocolos generales Vall d'Hebron, para la evaluación neuropsicológica en patología vascular cerebral adaptados a secuelas neurológicas a realizar en estadios iniciales de la demencia. *Weschler Memory Scale - III** Escala de Inteligencia para Adultos – III*** Boston Diagnostic Aphasia Examination. (Continuación)

PACIENTES CON HEMIPARESIA EN MANO DOMINANTE
Funciones atencionales y ejecutivas: Dígitos directos e inversos WAIS-III. Stroop Color Word Interference Test. Symbol Digits Modalities Test, versión oral. Cálculo mental o escrito. FAS (palabras que empiecen por F, A y S).
Lenguaje: Boston Naming Test 30 ítems. Token Test o comprensión de órdenes BDAE. Repetición pseudopalabras BDAE. Repetición frases BDAE. Animales, durante 1 minuto.
Memoria: Audioverbal: lista de 15 palabras de Rey. Visual: 10/36 y de elección de Benton (15 ítems). Orientación temporal de Benton. Animales, durante 1 minuto. Trabajo: dígitos inversos WAIS-III.
Funciones visuoperceptivas, visuoespaciales y visuoestructurivas: Orientación de líneas Benton. Hooper Visual Organization Test (con componente ejecutivo).
Control motor cognitivo voluntario: Grooved Pegboard o Finger Tapping en mano no dominante.
Velocidad: Motora: Grooved Pegboard o Finger Tapping en mano no dominante. Procesamiento información: Symbol Digits Modalities Test, versión oral.

Protocolos generales Vall d'Hebron, para la evaluación neuropsicológica en patología vascular cerebral adaptados a secuelas neurológicas a realizar en estadios iniciales de la demencia. *Weschler Memory Scale - III** Escala de Inteligencia para Adultos – III*** Boston Diagnostic Aphasia Examination. (Continuación)

PACIENTES CON AFASIA EVIDENTE Y HEMIPARESIA EN MANO DOMINANTE
Funciones atencionales y ejecutivas: Corsi's Block Tapping Test directos e inversos. Symbol Digits Modalities Test, versión oral.
Lenguaje: Boston Naming Test 30 ítems. Token test o comprensión de órdenes BDAE. Repetición pseudopalabras BDAE. Repetición frases BDAE. Animales, durante 1 minuto. FAS.
Memoria: Visual: 10/36 y de elección de Benton (15 ítems). Orientación temporal de Benton en láminas. Trabajo: Corsi's Block Tapping Test inversos.
Funciones visuoperceptivas, visuoespaciales y visuoestructurivas: Orientación de líneas de Benton. Cubos WAIS-III.
Control motor cognitivo voluntario: Grooved Pegboard o Finger Tapping en mano no dominante.
Velocidad: Motora: Grooved Pegboard o Finger Tapping en mano no dominante.

Protocolos generales Vall d'Hebron, para la evaluación neuropsicológica en patología vascular cerebral adaptados a secuelas neurológicas a realizar en estadios iniciales de la demencia. *Weschler Memory Scale
- III** Escala de Inteligencia para Adultos – III*** Boston Diagnostic Aphasia Examination.

A partir de su protocolo correspondiente, se irá incluyendo alguna otra prueba en base al rendimiento que vamos observando a lo largo de la evaluación; a las dificultades que tiene en su vida diaria, detectadas en la entrevista clínica inicial realizada con el paciente y con un informador (familiar, cuidador o alguien que conociera al paciente con anterioridad) y al territorio vascular o las lesiones que se han podido observar en las pruebas de neuroimagen.

En el caso, por ejemplo, de ictus en la arteria cerebral posterior izquierda, profundizaremos en la exploración de la lectura y la escritura, la denominación y el reconocimiento de colores o el aprendizaje audioverbal, etc. En el caso de ictus en la arteria cerebral anterior, exploraremos las áreas premotoras con pruebas de secuencias motoras, gráficas, ritmos, etc. Cuando tengamos sospecha de heminatención de un campo visual, utilizaremos el Line Bisection Test y el Bell's Test. También ante la sospecha de agnosia digital (alteración en el reconocimiento de dedos) o de síndrome de Gerstmann, incluiremos la prueba de reconocimiento digital de Benton. Para estudiar la disfunción ejecutiva, en algunos casos, será conveniente incluir una prueba adicional. Aconsejamos, en este caso, incluir el CAT (test de categorías de la Batería Halstead-Reitan del grupo de Tucson, que es una prueba de solución de problemas) y el Wisconsin Card Sorting Test o la torre de Londres.

De todos modos, las **baterías neuropsicológicas** generales empleadas con más frecuencia en casos de posible demencia vascular son, principalmente, la Mattis Dementia Rating Scale (Vangel y Lichtenberg, 1995), el ADAS (Alzheimer Disease Assessment Scale)(Peña-Casanova, Aguilar, Santacruz y colaboradores, 1997; Pascual, Saz, Larumbe, et al., 1997), la CERAD (Consistorium to Establish a Registry for Alzheimer's Disease)(Morris, Heyman, Mohs, et al., 1989) y el CAMDEX-R (versión revisada de la Cambridge Dementia Examination) principalmente. Respecto al CAMDEX, recientemente ha aparecido **una versión abreviada** de la parte cognitiva de la escala (R-CAMCOG)(De Koning, Dippel, van Kooten y Koudstaal, 2000; De Koning, van Kooten, Dippel, et al., 1998) que, en principio, parece de utilidad para detectar demencia mediante una forma breve de **evaluación en pacientes** que han presentado un ictus. Es mejor realizar un protocolo **específico y flexible**, orientado al paciente en base a todo lo comentado anteriormente, a sus características demográficas o culturales y al **grado de deterioro**, tal y como se especifica en la tabla 7. En este sentido, en pacientes que no saben **perfectamente el abecedario** de la "A" a la "L", en lugar del Trail Making Test, utilizaremos el Stroop Color Word Interference Test (versión con cuatro láminas); mejor utilizar la comprensión de órdenes de la BDAE, cuando el Token Test está muy alterado y, si el **nivel es muy bajo** (analfabetos), utilizaremos los cubos de la WAIS-III en lugar de utilizar la figura compleja de Rey (versión Meyers y Meyers). En lugar de la figura compleja de Rey, la posibilidad de incluir, en la

evaluación, la **prueba de memoria visual** de la WMS-III que incluye una fase de **copia y discriminación** de formas de las figuras incluidas, o la versión simplificada de la figura compleja de **Rey de Davis** (Freeman, Giovannetti, Lamar, et al., 2000), en el caso de que el nivel de estudios sea **inferior a primaria completa**.

En la figura 1 del Anexo, podemos observar la evolución a los seis meses en la copia de esta figura compleja de rey, de un caso de demencia vascular tras infarto en la ACM izquierda.

El test de las A's de Strub y Black es aconsejable como prueba de atención selectiva en niveles culturales muy bajos.

Cuando el paciente presenta déficit visual, incluiremos, como prueba de control motor y velocidad motora, el Finger Tapping Test de la batería Halstead Reitan en lugar del Grooved Pegboard. A medida que aumenta el grado de deterioro, se irán simplificando las pruebas (listas de 9 palabras en lugar de 15 o 16, según si hemos utilizado el Auditory Verbal Learning Test de Rey o el California Verbal Learning Test), hasta utilizar pruebas ya indicadas para demencias graves como son el TSI (Albert y Cohen, 1992) (Test for Severe Impairment, prueba breve del estilo del MEC) SIB (Llinás, et al. 1995) (Severe Impairment Battery) o el SCIP20 (Severe Cognitive Impairment Profile). Se propone la evaluación en estos casos mediante el TSI, el SIB y el SCIP, repartidos en dos sesiones de evaluación.